جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سومة يوسف الصاوى يوسف

المحافظة : الشرقيه **الحي / المدينة :** ابوكبير **العنوان :** نزلة العارين ابو كبير الشرقية

رقم البطاقة : 27008241300822 **رقم التليفون :** 01065496122 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 24-08-1970 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:(----------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ----------**قسم :** ----------

جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------

ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سومة يوسف الصاوى يوسف
National ID: 27008241300822



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



859

National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

٢٧٠٠٨٢٤١٣٠٠٨٢٢ ٢٠٢٣/٠٨
ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
محمد عبدالمقصود قناوى
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/٢١

٨

National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: سوما يوسف الصاوي يوسف **MR. :** 5800	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is receiving adjuvant PHESGO therapy, currently at cycle 15. An echocardiogram performed on day 3 of the 12-day cycle shows a left ventricular ejection fraction of 63%. Pharmacy has noted the patient is also on cycles 16 and 17 of an unspecified regimen. The patient has completed 15 cycles of PHESGO to date.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		

يعتمد ,

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 6/7/2025 G

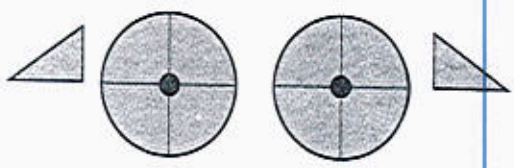
Name	سومة يوسف إسماعيل	MRN	302/2025
		ID	27008241300822
Age	54	Phone	
Menopausal status	Postmenop	Marital status	married
NRS SCORE	Post Meno	Family history	-ve
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity	ATN		

Clinical Data

BX: IDC

ER: 2/8	PR: 2/8	HER 2: 3	Ki67:

R cT4bN3cM0 L



Sonomammography:

Mets Workup:

Patient recieved TCHP x6 last TNM on 25/5/2025

⇒ Lt MRM + it ALND

Recommendations: YPT0, YPN0 for adjuvant Rheyo + pORTh

PORTh ⇒ ✓

MDT OUTCOME & PLAN

Dr Adj Rhesyo → PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name	:	Request No.	: 13002658
Patient No.	: 27008241300822	Request Date	: 24/06/2025
Path No.	: 2130/25	Verification Date	: 29/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy.

Gross Examination:

- Left modified radical mastectomy specimen measured 22x15x4 cm; with covering skin measured 22x15 cm.
- N&A: Looked unremarked grossly.
- Serialling showed tumor bed site 11x7x3 cm, located 1 cm from the deep margin.
- Axillary fat measured 7x6 cm; entangling 17 lymph nods, up to 1.5x1x0.5 cm.

- 25 Blocks:

1:19- T.B.S., 20- N& A., 21- Deep margin., 22:25- LNs.

- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

Microscopic Examination:

- Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.
- Cellularity (0%).
- Angiomvasion: Not detected.
- Ductal carcinoma in situ: Not detected.
- Additional findings: Effect of therapy (fibrosis & microcalcifications) and fibrocystic changes with apocrine metaplasia.
- Nipple & areola: Free.
- Resection Margin: Free deep margin.
- Axillary lymph nodes: 17 lymph nodes free of viable metastatic deposits, (0/17) (One lymph node showing effect of therapy).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Verified by :

شقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (982) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 982- Nile Cornicha - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

USTAVE /
OUSSY

Patient Name	:	Request No.	: 13002658
Patient No.	: 27008241300822	Request Date	: 24/06/2025
Path No.	: 2130/25	Verification Date	: 29/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:

Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy:

- No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.
- No DCIS.
- Deep Margin: Free.
- Nipple & areola: Free.
- Axillary lymph nodes: 17 lymph nodes free of viable metastatic deposits. LNs (0/17) (On lymph nodes showing effect of therapy).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
- Stage: ypT0, ypN0.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.
Dr. Heba Hassan Adly.

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Hour-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadeem - Cairo, Egypt

Pathology Report →
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Sharkia Diagnostic Center
(SHARKIA SCAN)
SDC
مركز الشرقية للأشعة والتشخيص
(الشرقية سكان)

Patient Name : Mrs./ SOMA YOSIEF EL SAWY .
Refering Doctor : Prof. Dr./ MOHAMED EL NAGY EL HIWAN.
Date : 18-Jan-25

REPORT

PLAIN RADIOGRAPHY OF CHEST AND HEART REVEALS:

= Normal cardiac shadow size & configuration..

= Both lung fields and costo-phrenic angles are clear with no pulmonary opacities.

= No pulmonary TB nor cavitations.

= Central position of the trachea and mediastinum.

= No mediastinal lymphadenopathy.

= Normal thoracic bony cage.

Thanks For Reference
Yours
Dr. Ahmed A. Azim.

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Dr. Khald Abdul Aziz

Lecturer & Consultant of Radiology
Zagazig University
M.D.Diagnostic Radiology

Dr. Khald Abdul Aziz
SonoScan

د. خالد عبد العزيز

مدرس وإستشارى الأشعة
بكلية الطب - جامعة الزقازيق
دكتوراه الأشعة التشخيصية

Name: Mrs. Soma Youssef El-Sawy **Date:** 21/07/2025

Ref. By: Prof. Dr. Ahmad Soliman

MULTI-SLICE PET/CT EXAMINATION OF THE BODY:

Clinical History:

- *A 55 y/o female with history of Lt. breast cancer. Her PET/CT done outside-home in January 2025 revealed FDG avid Lt. breast mass and enlarged Lt. axillary LN.s; hence, she underwent MRM, followed by chemo-targeted therapy till May 2025.*
- ***PET/CT is requested for status evaluation and follow up.***

Technique:

- *For the aforementioned patient we have done a total body PET scan one hour after IV injection of 300 MBq of 18 F-FDG.*
- *16 MSCT was performed using Siemens Biograph simultaneously and used for attenuation correction, anatomical localization and diagnosis.*
- *Max. variant of SUV; a Semi-quantitative analysis would be done for selected ROI.s and the normal threshold is < 3 (Vs. 2.5 before).*

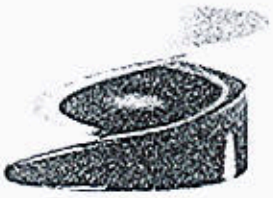
Findings:

A) Lt. Mastectomy Bed, Rt. Breast and Mammary-Related LN.s:

- Evidence of Lt. mastectomy with no residual/recurrent definite sizable masses or evidently dense tracer fixing foci seen; yet, diffuse subcutaneous fat stranding harboring diffuse mildly increased tracer uptake with **SUVmax up to 1.6**; likely representing **Surgery-Related Changes.**
- Normal Rt. breast appearance with no defnite :masses or dense tracer fixing foci.
- No pathologic enlarged or dense tracer fixing mammary related LN.s seen.

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Dr. Khald Abdul Aziz
Lecturer & Consultant of Radiology
Zagazig University
M.D.Diagnostic Radiology



Dr. Khald Abdul Aziz
SonoScan

د. خالد عبد العزيز
مدرس وإستشارى الأشعة
بكلية الطب - جامعة الزقازيق
دكتوراه الأشعة التشخيصية

B) Head and Neck:

- Normal appearance of nasopharynx, oropharynx and larynx.
- Diffuse mildly enlarged thyroid gland is still seen harboring diffuse heterogeneous increased tracer uptake with **SUVmax up to 2.9**; possibly of **Benign Inflammatory Nature** (i.e.: **Thyroiditis**); warranting further **U/S** evaluation.

- Normal appearance of submandibular and parotid salivary glands.
- No pathologic enlarged or dense tracer fixing cervical LN.s seen.

C) Chest:

- Clear both lung fields with no definite nodules or parenchymal infiltrates seen.
- No evidence of pleural or pericardial effusion detected.
- No pathologic enlarged or dense tracer fixing hilar or mediastinal LN.s seen.

D) Abdomen and Pelvis:

- Mild hepatomegaly showing homogenous tracer uptake and CT fatty texture with no definite focal lesions (on non-contrast CT basis), dense tracer fixing foci or biliary radicle dilatation noted.
- Normal size, parenchymal tracer uptake and CT texture of the spleen, pancreas and both. adrenal glands with no definite focal lesions (on non-contrast CT basis) or dense tracer fixing foci noted.
- Normal size, parenchymal thickness and density of both kidneys showing no stones or backpressure changes with average rate of dense tracer washout.
- Normal tracer uptake pattern and non-contrast CT appearance of pelvic organs.

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Dr. Khald Abdul Aziz
Lecturer & Consultant of Radiology
Zagazig University
M.D.Diagnostic Radiology

د. خالد عبد العزيز
مدرس وإستشارى الأشعة
بكلية الطب - جامعة الزقازيق
دكتوراه الأشعة التشخيصية

Dr. Khald Abdul Aziz
SonoScan

- No pathologic enlarged or dense tarcer fixing abdomino-pelvic LN.s noted.
- No evidence of ascites, abdominal or pelvic fluid collections noted.

E) Bony Skeleton:

- Normal appearance of the bony skeleton with no evidence of any abnromal avid focal tracer uptake could be seen at any region.

Opinion and Prior Study Comparison (January 2025):

- The current study findings are of:
  - ✓ *Clear Lt. mastectomy bed with no current metabolically active masses.*
  - ✓ *Free rest of the surveyed body from any significant glucose avid foci that would assign to any serious pathology.*

- These findings are collectively reflective of:

Satisfactory Study Results and Current, Macroscopically Metabolic Disease Free Body

- Follow up **PET/CT** as clinically warranted would be advisable.

Thanks for your referral,
Truly yours,
Dr. Waleed Alaa El-Hosary.
Dr. Mohamed Hassan Hassouna, MSc.
Dr. Mohamed Fat'hy Ragab, MD.

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Patient's Name:	**Soma Youssef El-Sawy Youssef**
Date:	**2026-05-13**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE NECK, CHEST, ABDOMEN AND PELVIS AFTER ORAL AND I.V. CONTRAST INJECTION REVEALED:

Known case of breast CA underwent left MRM. no available DICOM images for comparison.

I- NECK:

- Normal appearance of the naso-, oro- and hypopharynx with preserved parapharyngeal fat planes.
- Intact laryngeal skeleton with no glottic, supra or infra glottic masses.
- Normal course and calibre of the carotid and jugular vessels.
- Normal CT appearance of the submandibular and parotid salivary glands showing homogenous enhancement. No focal solid or cystic lesions.
- Few subscentemetric bilateral deep cervical and submandibular LNs are noted; largest measuring 14 x 8 mm at the right deep cervical region.
- No pathologically enlarged cervical lymph nodes.

II- CHEST:

- Few bilateral scattered small pulmonary nodules largest measuring 5.7 mm at the right upper lobe.
- No puimonary masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Bilateral elastofibroma dorsi.

III-ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient's Name:	**Soma Youssef El-Sawy Youssef**
Date:	**2026-05-13**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Multiple subcentimetric para-aortic and bilateral external iliac lymph nodes.
- No ascites.

Opinion:

❖ **Few bilateral scattered small pulmonary nodules for follow up.**

Dr.sherif Wagdy

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]